

Krew pępowinowa: kiedy bankowanie ma sens i ile kosztuje?



Szybka odpowiedź

Krew pępowinowa jest uznanym źródłem komórek krwiotwórczych w leczeniu wybranych chorób krwi, odporności i metabolizmu. Nie jest polisą na każdą przyszłą chorobę. AAP w polityce ponownie zatwierdzonej w kwietniu 2026 r. preferuje bankowanie publiczne, a prywatne wiąże przede wszystkim ze znaną potrzebą medyczną w rodzinie.

Kluczowe wnioski

- Komórki z krwi pępowinowej mają realne zastosowania transplantacyjne, ale nie leczą dowolnej choroby.
- Własny materiał może nie nadawać się do leczenia choroby genetycznej lub części nowotworów tego samego dziecka.
- Bank publiczny i prywatny realizują inne cele; darowizna publiczna nie rezerwuje materiału dla rodziny.
- Porównując cenę, zsumuj opłatę początkową, badania, przechowywanie, indeksację i warunki zakończenia umowy.

Co rzeczywiście leczy się krwią pępowinową?

Komórki krwiotwórcze z krwi pępowinowej wykorzystuje się w transplantologii między innymi w wybranych białaczkach, chłoniakach, hemoglobinopatiach, ciężkich niedoborach odporności i niektórych chorobach metabolicznych. To leczenie konkretnych rozpoznań po kwalifikacji transplantacyjnej, a nie ogólna „regeneracja organizmu”.

Zastosowania regeneracyjne badane w próbach klinicznych nie są tym samym co rutynowa terapia. Jak odróżnić wynik badania od obietnicy sprzedażowej, pokazuje [poradnik oceny obietnic medycznych](#) oraz analiza [badań klinicznych i AI](#).



Krew pępowinowa ma uznane zastosowania transplantacyjne, ale jednostka jest kwalifikowana do konkretnego biorcy i rozpoznania.

Dlaczego własny materiał nie zawsze pomoże dziecku?

W chorobie genetycznej własna krew może zawierać tę samą zmianę, a przy części białaczek materiał pobrany przy urodzeniu może zawierać komórki poprzedzające chorobę. Dlatego autologiczny depozyt nie jest automatycznie bezpiecznym wyborem; o źródle komórek decyduje zespół transplantacyjny.

Najważniejsze pytanie brzmi nie „czy komórki są cenne?“, lecz „czy ta jednostka pasuje do tego rozpoznania i biorcy?“. Czasem właściwszy jest zgodny dawca rodzinny lub niespokrewniony. Mechanizmy dziedziczenia od testów konsumenckich odróżnia artykuł [o metylacji DNA](#).

Jak to zastosować?

Pytaj o wskazanie, zgodność i możliwość wydania materiału, a nie tylko o hasło „zabezpieczenie przyszłości“.



Własny depozyt nie zawsze nadaje się do leczenia własnej choroby; znaczenie mają rozpoznanie, jakość jednostki i zgodność dawcy z biorcą.

Bank publiczny czy prywatny - czym się różnią?

Darowizna do banku publicznego zasila pulę dla zgodnego biorcy i nie rezerwuje jednostki dla rodziny. Bank prywatny przechowuje materiał dla wskazanej rodziny za opłatą. AAP i ACOG preferują model publiczny, gdy jest dostępny; bankowanie rodzinne ma najmocniejsze uzasadnienie przy znanej chorobie krewnego, dla którego rozważa się przeszczepienie.

Przed decyzją poproś o akredytację, kryteria jakości, warunki wydania oraz liczbę jednostek rzeczywiście użytych do leczenia. Liczba przechowywanych próbek nie mówi, ile z nich podano pacjentom. Do rozmowy przygotuj udokumentowaną historię rodzinną, tak jak do [planowania badań i konsultacji](#).



Darowizna publiczna służy zgodnemu biorcy, a prywatny bank rezerwuje materiał dla rodziny i pobiera opłaty za usługę.

Jak policzyć pełny koszt bankowania?

Nie porównuj samej opłaty startowej. Zsumuj pobranie, badania, raty po porodzie i cały planowany okres przechowywania. Sprawdź też waloryzację, koszt transportu i wydania materiału, zasady przy zbyt małej liczbie komórek oraz warunki rozwiązania umowy.

Na 27 września 2026 r. publiczny cennik PBKM dla podstawowego wariantu ciąży pojedynczej pokazywał 199 zł po podpisaniu umowy, 10 × 299 zł po badaniach i 59 zł miesięcznie od roku po porodzie. Przy niezmiennych stawkach 20 lat daje 16 641 zł: 199 + 2 990 + 228 × 59. To przykład rachunku przed indywidualną promocją i ewentualną waloryzacją.

Warunek bezpieczeństwa

Cena z promocji ma datę ważności. Zawsze oblicz pełny koszt umowy, łącznie z wieloletnim przechowywaniem.

Publiczne i prywatne bankowanie

Pytanie	Bank publiczny	Bank prywatny
Dla kogo?	Dla zgodnego biorcy	Dla rodziny zgodnie z umową
Opłata rodziny	Zwykle brak	Opłaty początkowe i okresowe
Dostępność	Tylko wybrane placówki	Zależna od oferty firmy
Główne uzasadnienie	Zasób dawców	Konkretne wskazanie rodzinne lub wybór rodziców



Pełny koszt obejmuje wszystkie etapy umowy i wieloletni abonament, a nie tylko promocyjną opłatę początkową.

Krew pępowinowa jest wartościowym materiałem transplantacyjnym, ale wartość medyczna nie oznacza, że każdy prywatny depozyt zostanie wykorzystany.

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto bankować krew pępowinową prywatnie?

Najsilniejszym wskazaniem jest konkretny chory krewny, dla którego transplantolog rozważa taki materiał. Rutynowe bankowanie nie jest zalecane przez ACOG.

Czy krew pępowinowa leczy autyzm lub porażenie mózgowe?

Takie zastosowania są badane, ale nie należy przedstawiać ich jako rutynowych, potwierdzonych terapii dostępnych z każdego depozytu.

Czy własna krew może leczyć białaczkę?

Nie zawsze; zależy to od choroby, jakości materiału i ryzyka obecności komórek związanych z chorobą. Decyduje transplantolog.

Ile kosztuje przechowywanie?

Koszt zależy od wariantu i czasu. Na 27 września 2026 r. podstawowy cennik PBKM dla ciąży pojedynczej wskazywał 199 zł, 10 × 299 zł i następnie 59 zł miesięcznie; trzeba uwzględnić promocje, waloryzację i warunki umowy.

Źródła

1. [ACOG: stanowisko w sprawie bankowania krwi pępowinowej](#)
2. [AAP: polityka bankowania krwi pępowinowej, ponownie zatwierdzona w 2026 r.](#)
3. [Przegląd kliniczny: zastosowania i ograniczenia bankowania krwi pępowinowej](#)
4. [PBKM: publiczny cennik usługi \(dostęp 27.09.2026\)](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.